

Répertoire de Néphrologie 6^e année

F Fakhouri
Service de Néphrologie, CHUV

Une femme, âgée de 56 ans vous est adressée par son médecin traitant pour oedèmes des membres inférieurs présents depuis au moins 8 mois (prise de 6 Kg; poids actuel 66 Kg). La patiente n'a aucun autre antécédent. Elle a déjà consulté un allergologue et une cardiologue qui n'ont pas retrouvé d'anomalies particulières. Le médecin traitant a réalisé une bandelette urinaire que la patiente vous montre: Protéines +++++, Hématies ++.

1- Quels examens simples réalisez-vous dans un premier temps?

Une femme, âgée de 56 ans vous est adressée par son médecin traitant pour oedèmes des membres inférieurs présents depuis au moins 8 mois (prise de 6 Kg; poids actuel 66 Kg). La patiente n'a aucun autre antécédent. Elle a déjà consulté un allergologue et une cardiologue qui n'ont pas retrouvé d'anomalies particulières. Le médecin traitant a réalisé une bandelette urinaire que la patiente vous montre: Protéines +++++, Hématies ++.

1- Quels examens réalisez-vous dans un premier temps?

Un examen clinique, une mesure de: la créatininémie, la natrémie, la kaliémie, la protidémie, l'albuminémie, le rapport protéinurie/créatininurie et albuminémie/créatininurie.

Analyse du sédiment urinaire en contraste de phase.

Une femme, âgée de 56 ans vous est adressée par son médecin traitant pour oedèmes des membres inférieurs présents depuis au moins 8 mois (prise de 6 Kg; poids actuel 66 Kg). La patiente n'a aucun autre antécédent. Elle a déjà consulté un allergologue et une cardiologue qui n'ont pas retrouvé d'anomalies particulières. Le médecin traitant a réalisé une bandelette urinaire que la patiente vous montre: Protéines +++++, Hématies ++.

1- Quels examens réalisez-vous dans un premier temps?

2- Le bilan complémentaire montre: TA 145/95 mmHg. Purie/Crurie 1 g/mmol (Nal < 0.05 g/mmol), protidémie 54 g/l, albuminémie 23 g/l, Cr 121 micromol/l. L'étude du sédiment urinaire en contraste de phase montre 2-3 hématies/champ non déformées.

Comment interprétez-vous l'ensemble des données?

Une femme, âgée de 56 ans vous est adressée par son médecin traitant pour oedèmes des membres inférieurs présents depuis au moins 8 mois (prise de 6 Kg; poids actuel 66 Kg). La patiente n'a aucun autre antécédent. Elle a déjà consulté un allergologue et une cardiologue qui n'ont pas retrouvé d'anomalies particulières. Le médecin traitant a réalisé une bandelette urinaire que la patiente vous montre: Protéines +++++, Hématies ++.

1- Quels examens réalisez-vous dans un premier temps?

2- Le bilan complémentaire montre: TA 145/95 mmHg. Purie/Crurie 1 g/mmol (Nal < 0.05 g/mmol) et 4.6 g/24h, protidémie 54 g/l, albuminémie 23 g/l, Cr 121 micromol/l. L'étude du sédiment urinaire en contraste de phase montre 1-2 hématies/champ, non déformées.

Comment interprétez-vous l'ensemble des données?

Syndrome néphrotique et insuffisance rénale (aigue ou chronique).

Une femme, âgée de 56 ans vous est adressée par son médecin traitant pour oedèmes des membres inférieurs présents depuis au moins 8 mois (prise de 6 Kg; poids actuel 66 Kg). La patiente n'a aucun autre antécédent. Elle a déjà consulté un allergologue et une cardiologue qui n'ont pas retrouvé d'anomalies particulières. Le médecin traitant a réalisé une bandelette urinaire que la patiente vous montre: Protéines +++++, Hématies ++.

1- Quels examens réalisez-vous dans un premier temps?

2- Le bilan complémentaire montre: TA 145/95 mmHg. Purie/Crurie 1 g/mmol (Nal < 0.05 g/mmol) et 4.6 g/24h, protidémie 54 g/l, albuminémie 23 g/l, Cr 121 micromol/l. L'étude du sédiment urinaire en contraste de phase montre 2-3 hématies/champ non déformées.

Comment interprétez-vous l'ensemble des données?

3- Quelles sont vos hypothèses diagnostiques?

Une femme, âgée de 56 ans vous est adressée par son médecin traitant pour oedèmes des membres inférieurs présents depuis au moins 8 mois (prise de 6 Kg; poids actuel 66 Kg). La patiente n'a aucun autre antécédent. Elle a déjà consulté un allergologue et une cardiologue qui n'ont pas retrouvé d'anomalies particulières. Le médecin traitant a réalisé une bandelette urinaire que la patiente vous montre: Protéines +++++, Hématies ++.

1- Quels examens réalisez-vous dans un premier temps?

2- Le bilan complémentaire montre: TA 145/95 mmHg. Purie/Crurie 1 g/mmol (Nal < 0.05 g/mmol) et 4.6 g/24h, protidémie 54 g/l, albuminémie 23 g/l, Cr 121 micromol/l. L'étude du sédiment urinaire en contraste de phase montre 2-3 hématies non déformées. Comment interprétez-vous l'ensemble des données?

3- Quelles sont vos principales hypothèses diagnostiques?

Glomérulonéphrite extra-membraneuse, lésions glomérulaires minimes/HSF, amylose.
Et tout autre type de glomérulopathies!

Une femme, âgée de 56 ans vous est adressée par son médecin traitant pour oedèmes des membres inférieurs présents depuis au moins 8 mois (prise de 6 Kg; poids actuel 66 Kg). La patiente n'a aucun autre antécédent. Elle a déjà consulté un allergologue et une cardiologue qui n'ont pas retrouvé d'anomalies particulières. Le médecin traitant a réalisé une bandelette urinaire que la patiente vous montre: Protéines +++++, Hématies ++.

- 1- Quels examens réalisez-vous dans un premier temps?
- 2- Le bilan complémentaire montre: TA 145/95 mmHg. Purie/Crurie 1 g/mmol (Nal < 0.05 g/mmol) et 4.6 g/24h, protidémie 54 g/l, albuminémie 23 g/l, Cr 121 micromol/l. L'étude du sédiment urinaire en contraste de phase montre 2-3 Comment interprétez-vous l'ensemble des données?
- 3- Quelles sont vos principales hypothèses diagnostiques?
- 4- Comment confirmez-vous le diagnostic?

Une femme, âgée de 56 ans vous est adressée par son médecin traitant pour oedèmes des membres inférieurs présents depuis au moins 8 mois (prise de 6 Kg; poids actuel 66 Kg). La patiente n'a aucun autre antécédent. Elle a déjà consulté un allergologue et une cardiologue qui n'ont pas retrouvé d'anomalies particulières. Le médecin traitant a réalisé une bandelette urinaire que la patiente vous montre: Protéines +++++, Hématies ++.

- 1- Quels examens réalisez-vous dans un premier temps?
- 2- Le bilan complémentaire montre: TA 145/95 mmHg. Purie/Crurie 1 g/mmol (Nal < 0.05 g/mmol) et 4.6 g/24h, protidémie 54 g/l, albuminémie 23 g/l, Cr 121 micromol/l. L'étude du sédiment urinaire en contraste de phase montre 2-3 Comment interprétez-vous l'ensemble des données?
- 3- Quelles sont vos principales hypothèses diagnostiques?
- 4- Comment confirmez-vous le diagnostic?

Réalisation d'une ponction-biopsie rénale.

Une femme, âgée de 56 ans vous est adressée par son médecin traitant pour oedèmes des membres inférieurs présents depuis au moins 8 mois (prise de 6 Kg; poids actuel 66 Kg). La patiente n'a aucun autre antécédent. Elle a déjà consulté un allergologue et une cardiologue qui n'ont pas retrouvé d'anomalies particulières. Le médecin traitant a réalisé une bandelette urinaire que la patiente vous montre: Protéines +++++, Hématies ++.

- 1- Quels examens réalisez-vous dans un premier temps?
- 2- Le bilan complémentaire montre: TA 145/95 mmHg. Purie/Crurie 1 g/mmol (Nal < 0.05 g/mmol) et 4.6 g/24h, protidémie 54 g/l, albuminémie 23 g/l, Cr 121 micromol/l. L'étude du sédiment urinaire en contraste de phase montre 2-3 hématies non déformées. Comment interprétez-vous l'ensemble des données?
- 3- Quelles sont vos principales hypothèses diagnostiques?
- 4- Comment confirmez-vous le diagnostic?
- 5- Quelles précautions prendre avant ce geste?

Une femme, âgée de 56 ans vous est adressée par son médecin traitant pour oedèmes des membres inférieurs présents depuis au moins 8 mois (prise de 6 Kg; poids actuel 66 Kg). La patiente n'a aucun autre antécédent. Elle a déjà consulté un allergologue et une cardiologue qui n'ont pas retrouvé d'anomalies particulières. Le médecin traitant a réalisé une bandelette urinaire que la patiente vous montre: Protéines +++++, Hématies ++.

- 1- Quels examens réalisez-vous dans un premier temps?
- 2- Le bilan complémentaire montre: TA 145/95 mmHg. Purie/Crurie 1 g/mmol (Nal < 0.05 g/mmol) et 4.6 g/24h, protidémie 54 g/l, albuminémie 23 g/l, Cr 121 micromol/l. L'étude du sédiment urinaire en contraste de phase montre 2-3 hématies non déformées. Comment interprétez-vous l'ensemble des données?
- 3- Quelles sont vos principales hypothèses diagnostiques?
- 4- Comment confirmez-vous le diagnostic?
- 5- Quelles précautions prendre avant ce geste?

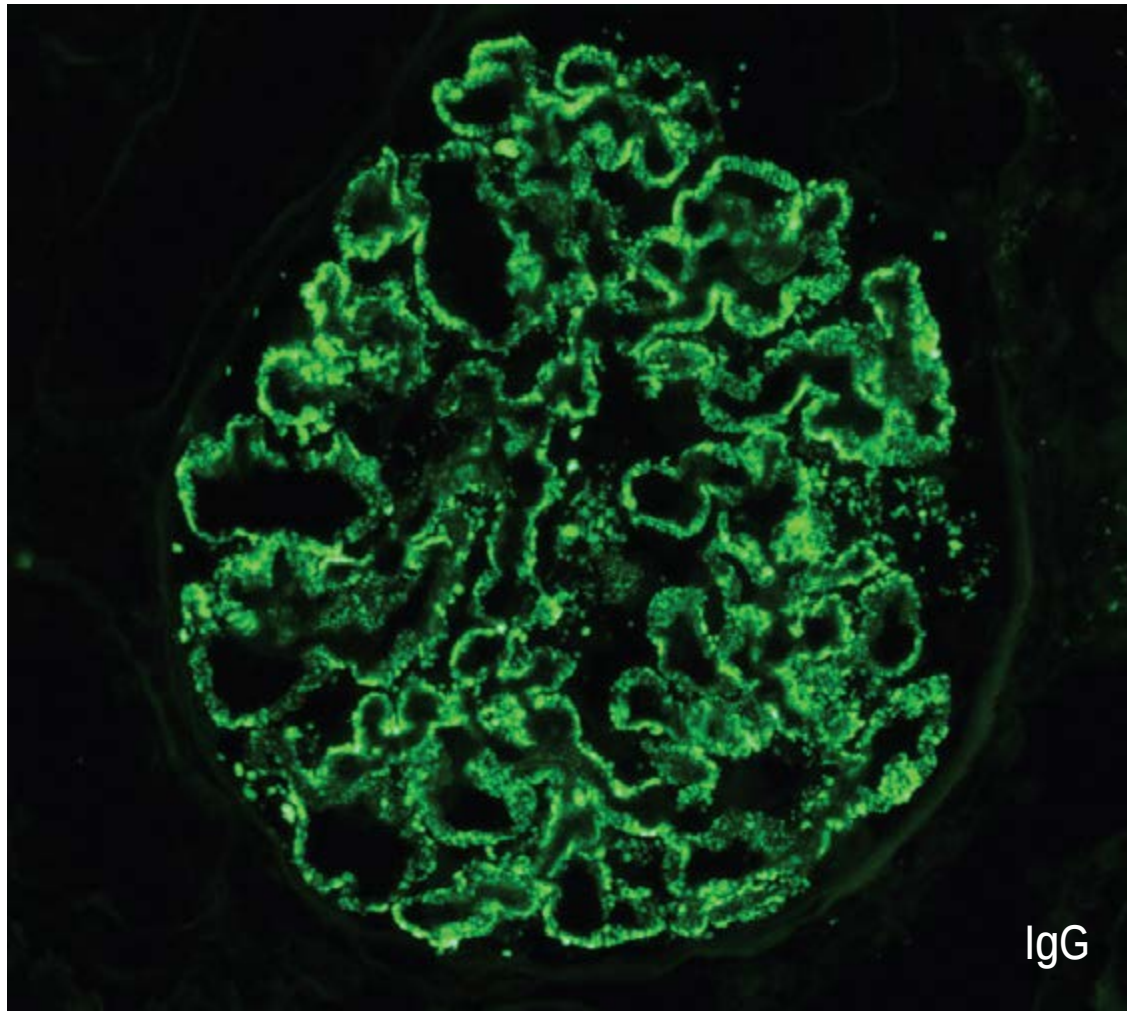
Contrôler:

- l'absence de traitement anticoagulant et/ou antiagrégant ou un trouble de la crase.
- le bon contrôle tensionnel (avec ou sans traitement).
- l'existence de deux reins à l'échographie rénale (et l'absence de thrombose veineuse rénale dans ce contexte de syndrome néphrotique).

Une femme, âgée de 56 ans vous est adressée par son médecin traitant pour oedèmes des membres inférieurs présents depuis au moins 8 mois (prise de 6 Kg; poids actuel 66 Kg). La patiente n'a aucun autre antécédent. Elle a déjà consulté un allergologue et une cardiologue qui n'ont pas retrouvé d'anomalies particulières. Le médecin traitant a réalisé une bandelette urinaire que la patiente vous montre: Protéines +++++, Hématies ++.

- 1- Quels examens réalisez-vous dans un premier temps?
- 2- Le bilan complémentaire montre: TA 145/95 mmHg. Purie/Crurie 1 g/mmol (Nal < 0.05 g/mmol) et 4.6 g/24h, protidémie 54 g/l, albuminémie 23 g/l, Cr 121 micromol/l. L'étude du sédiment urinaire en contraste de phase montre 2-3 hématies non déformées. Comment interprétez-vous l'ensemble des données?
- 3- Quelles sont vos principales hypothèses diagnostiques?
- 4- Comment confirmez-vous le diagnostic?
- 5- Quelles précautions prendre avant ce geste?
- 6- Le principal résultat de la ponction-biopsie rénale est indiqué dans la figure. Quel diagnostic retenir-vous?

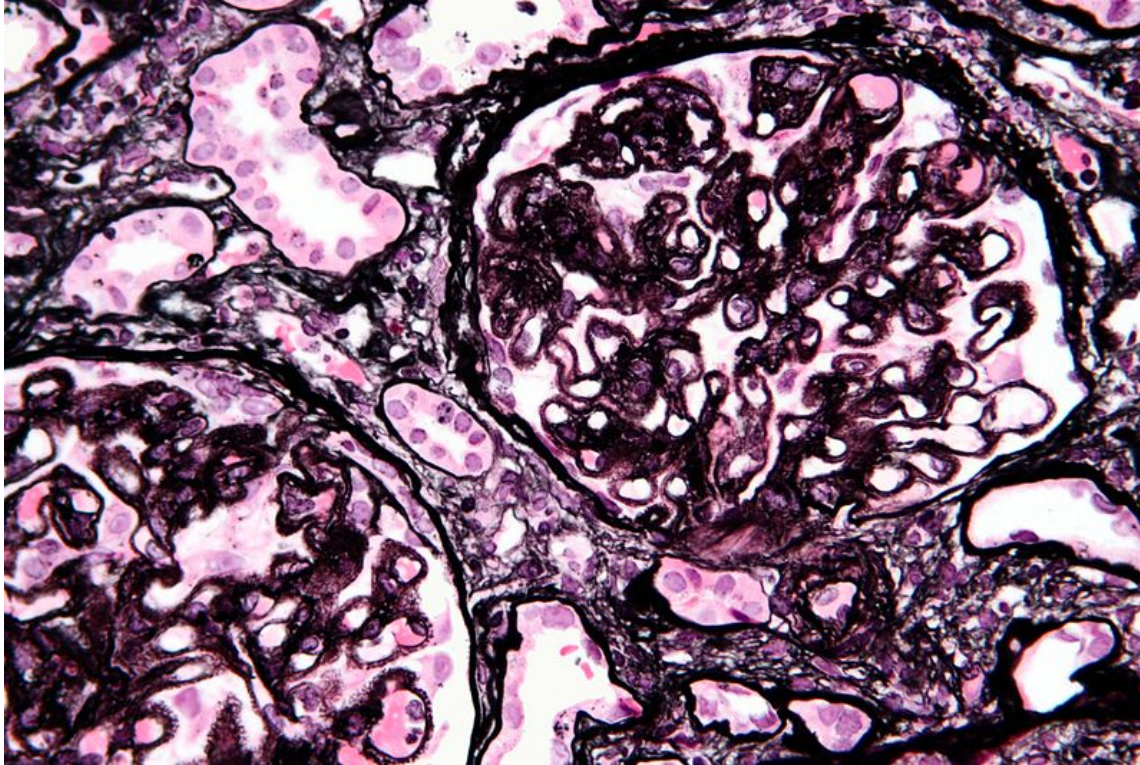
Examen en immunofluorescence.



Une femme, âgée de 56 ans vous est adressée par son médecin traitant pour oedèmes des membres inférieurs présents depuis au moins 8 mois (prise de 6 Kg; poids actuel 66 Kg). La patiente n'a aucun autre antécédent. Elle a déjà consulté un allergologue et une cardiologue qui n'ont pas retrouvé d'anomalies particulières. Le médecin traitant a réalisé une bandelette urinaire que la patiente vous montre: Protéines +++++, Hématies ++.

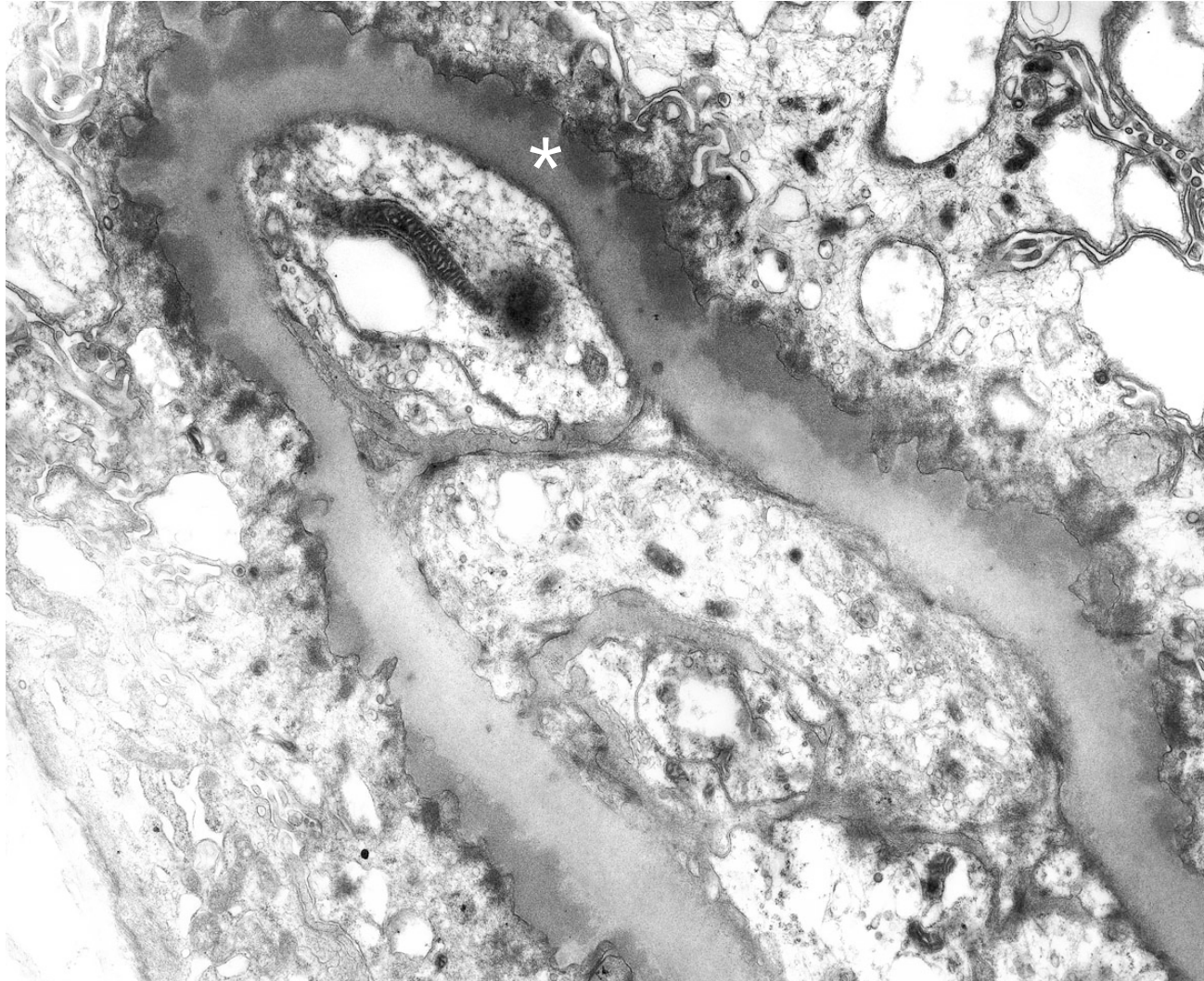
- 1- Quels examens réalisez-vous dans un premier temps?
- 2- Le bilan complémentaire montre: TA 145/95 mmHg. Purie/Crurie 1 g/mmol (Nal < 0.05 g/mmol) et 4.6 g/24h, protidémie 54 g/l, albuminémie 23 g/l, Cr 121 micromol/l. L'étude du sédiment urinaire en contraste de phase montre 2-3 hématies non déformées. Comment interprétez-vous l'ensemble des données?
- 3- Quelles sont vos principales hypothèses diagnostiques?
- 4- Comment confirmez-vous le diagnostic?
- 5- Quelles précautions prendre avant ce geste?
- 6- Le principal résultat de la ponction-biopsie rénale est indiqué dans la figure. Quel diagnostic retenir-vous?

Glomérulonéphrite extra-membraneuse.



GN extramembraneuse avec membrane basale glomérulaire épaissie (x400, coloration argentique)

Dépôts d'immunoglobulines dans la membrane basale glomérulaire



Une femme, âgée de 56 ans vous est adressée par son médecin traitant pour oedèmes des membres inférieurs présents depuis au moins 8 mois (prise de 6 Kg; poids actuel 66 Kg). La patiente n'a aucun autre antécédent. Elle a déjà consulté un allergologue et une cardiologue qui n'ont pas retrouvé d'anomalies particulières. Le médecin traitant a réalisé une bandelette urinaire que la patiente vous montre: Protéines +++++, Hématies ++.

- 1- Quels examens réalisez-vous dans un premier temps?
- 2- Le bilan complémentaire montre: TA 145/95 mmHg. Purie/Crurie 1 g/mmol (Nal < 0.05 g/mmol) et 4.6 g/24h, protidémie 54 g/l, albuminémie 23 g/l, Cr 121 micromol/l. L'étude du sédiment urinaire en contraste de phase montre 2-3 hématies non déformées. Comment interprétez-vous l'ensemble des données?
- 3- Quelles sont vos principales hypothèses diagnostiques?
- 4- Comment confirmez-vous le diagnostic?
- 5- Quelles précautions prendre avant ce geste?
- 6- Le principal résultat de la ponction-biopsie rénale est indiqué dans la figure. Quel diagnostic retenir?
- 7- Quel type d'anticorps est souvent associé à ce type de pathologie rénale?

Une femme, âgée de 56 ans vous est adressée par son médecin traitant pour oedèmes des membres inférieurs présents depuis au moins 8 mois (prise de 6 Kg; poids actuel 66 Kg). La patiente n'a aucun autre antécédent. Elle a déjà consulté un allergologue et une cardiologue qui n'ont pas retrouvé d'anomalies particulières. Le médecin traitant a réalisé une bandelette urinaire que la patiente vous montre: Protéines +++++, Hématies ++.

- 1- Quels examens réalisez-vous dans un premier temps?
- 2- Le bilan complémentaire montre: TA 145/95 mmHg. Purie/Crurie 1 g/mmol (Nal < 0.05 g/mmol) et 4.6 g/24h, protidémie 54 g/l, albuminémie 23 g/l, Cr 121 micromol/l. L'étude du sédiment urinaire en contraste de phase montre 2-3 hématies non déformées. Comment interprétez-vous l'ensemble des données?
- 3- Quelles sont vos principales hypothèses diagnostiques?
- 4- Comment confirmez-vous le diagnostic?
- 5- Quelles précautions prendre avant ce geste?
- 6- Le principal résultat de la ponction-biopsie rénale est indiqué dans la figure. Quel diagnostic retenir?
- 7- Quel type d'anticorps est souvent associé à ce type de pathologie rénale?

Anticorps anti-PLA2R (récepteur phospholipase A2 de type M)

Une femme, âgée de 56 ans vous est adressée par son médecin traitant pour oedèmes des membres inférieurs présents depuis au moins 8 mois (prise de 6 Kg; poids actuel 66 Kg). La patiente n'a aucun autre antécédent. Elle a déjà consulté un allergologue et une cardiologue qui n'ont pas retrouvé d'anomalies particulières. Le médecin traitant a réalisé une bandelette urinaire que la patiente vous montre: Protéines +++++, Hématies ++.

- 1- Quels examens réalisez-vous dans un premier temps?
- 2- Le bilan complémentaire montre: TA 145/95 mmHg. Purie/Crurie 1 g/mmol (Nal < 0.05 g/mmol) et 4.6 g/24h, protidémie 54 g/l, albuminémie 23 g/l, Cr 121 micromol/l. L'étude du sédiment urinaire en contraste de phase montre 2-3 hématies non déformées. Comment interprétez-vous l'ensemble des données?
- 3- Quelles sont vos principales hypothèses diagnostiques?
- 4- Comment confirmez-vous le diagnostic?
- 5- Quelles précautions prendre avant ce geste?
- 6- Le principal résultat de la ponction-biopsie rénale est indiqué dans la figure. Quel diagnostic retenir?
- 7- Quel type d'anticorps est souvent associé à ce type de pathologie rénale?
- 8- La recherche d'anticorps est négative. Y-a-t il d'autres examens à réaliser?

Une femme, âgée de 56 ans vous est adressée par son médecin traitant pour oedèmes des membres inférieurs présents depuis au moins 8 mois (prise de 6 Kg; poids actuel 66 Kg). La patiente n'a aucun autre antécédent. Elle a déjà consulté un allergologue et une cardiologue qui n'ont pas retrouvé d'anomalies particulières. Le médecin traitant a réalisé une bandelette urinaire que la patiente vous montre: Protéines +++++, Hématies ++.

- 1- Quels examens réalisez-vous dans un premier temps?
- 2- Le bilan complémentaire montre: TA 145/95 mmHg. Purie/Crurie 1 g/mmol (Nal < 0.05 g/mmol) et 4.6 g/24h, protidémie 54 g/l, albuminémie 23 g/l, Cr 121 micromol/l. L'étude du sédiment urinaire en contraste de phase montre 2-3 hématies non déformées. Comment interprétez-vous l'ensemble des données?
- 3- Quelles sont vos principales hypothèses diagnostiques?
- 4- Comment confirmez-vous le diagnostic?
- 5- Quelles précautions prendre avant ce geste?
- 6- Le principal résultat de la ponction-biopsie rénale est indiqué dans la figure. Quel diagnostic retenir-vous?
- 7- Quel type d'anticorps est souvent associé à ce type de pathologie rénale?
- 8- La recherche d'anticorps est négative. Y-a-t-il d'autres examens à réaliser en priorité?

Recherche d'une néoplasie dans l'hypothèse d'une GEM secondaire: sein (mammographie) côlon (coloscopie), poumons (scanner), principalement.

Une femme, âgée de 56 ans vous est adressée par son médecin traitant pour oedèmes des membres inférieurs présents depuis au moins 8 mois (prise de 6 Kg; poids actuel 66 Kg). La patiente n'a aucun autre antécédent. Elle a déjà consulté un allergologue et une cardiologue qui n'ont pas retrouvé d'anomalies particulières. Le médecin traitant a réalisé une bandelette urinaire que la patiente vous montre: Protéines +++++, Hématies ++.

- 1- Quels examens réalisez-vous dans un premier temps?
- 2- Le bilan complémentaire montre: TA 145/95 mmHg. Purie/Crurie 1 g/mmol (Nal < 0.05 g/mmol) et 4.6 g/24h, protidémie 54 g/l, albuminémie 23 g/l, Cr 121 micromol/l. L'étude du sédiment urinaire en contraste de phase montre 2-3 hématies non déformées. Comment interprétez-vous l'ensemble des données?
- 3- Quelles sont vos principales hypothèses diagnostiques?
- 4- Comment confirmez-vous le diagnostic?
- 5- Quelles précautions prendre avant ce geste?
- 6- Le principal résultat de la ponction-biopsie rénale est indiqué dans la figure. Quel diagnostic retenir-vous?
- 7- Quel type d'anticorps est souvent associé à ce type de pathologie rénale?
- 8- La recherche d'anticorps est négative. Y-a-t il d'autres examens à réaliser en priorité?
- 9- Cinq jours après la biopsie rénale, la patiente présente une douleur lombaire aiguë et une hématurie macroscopique. Quelles sont vos 2 principales hypothèses diagnostiques? Quel(s) examen(s) réalisez-vous?

Une femme, âgée de 56 ans vous est adressée par son médecin traitant pour oedèmes des membres inférieurs présents depuis au moins 8 mois (prise de 6 Kg; poids actuel 66 Kg). La patiente n'a aucun autre antécédent. Elle a déjà consulté un allergologue et une cardiologue qui n'ont pas retrouvé d'anomalies particulières. Le médecin traitant a réalisé une bandelette urinaire que la patiente vous montre: Protéines +++++, Hématies ++.

- 1- Quels examens réalisez-vous dans un premier temps?
- 2- Le bilan complémentaire montre: TA 145/95 mmHg. Purie/Crurie 1 g/mmol (Nal < 0.05 g/mmol) et 4.6 g/24h, protidémie 54 g/l, albuminémie 23 g/l, Cr 121 micromol/l. L'étude du sédiment urinaire en contraste de phase montre 2-3 hématies non déformées. Comment interprétez-vous l'ensemble des données?
- 3- Quelles sont vos principales hypothèses diagnostiques?
- 4- Comment confirmez-vous le diagnostic?
- 5- Quelles précautions prendre avant ce geste?
- 6- Le principal résultat de la ponction-biopsie rénale est indiqué dans la figure. Quel diagnostic retenez-vous?
- 7- Quel type d'anticorps est souvent associé à ce type de pathologie rénale?
- 8- La recherche d'anticorps est négative. Y-a-t il d'autres examens à réaliser en priorité?
- 9- Cinq jours après la biopsie rénale, la patiente présente une douleur lombaire aiguë et une hématurie macroscopique. Quelles sont vos 2 principales hypothèses diagnostiques? Quel(s) examen(s) réalisez-vous?

Hématome périrénal (ou intra-rénal $\pm$ faux anévrisme) (complication de la biopsie).
Thrombose d'une veine rénale (complication du syndrome néphrotique).
Echographie-doppler ou angioscanner rénal.

Une femme, âgée de 56 ans vous est adressée par son médecin traitant pour oedèmes des membres inférieurs présents depuis au moins 8 mois (prise de 6 Kg; poids actuel 66 Kg). La patiente n'a aucun autre antécédent. Elle a déjà consulté un allergologue et une cardiologue qui n'ont pas retrouvé d'anomalies particulières. Le médecin traitant a réalisé une bandelette urinaire que la patiente vous montre: Protéines +++++, Hématies ++.

- 1- Quels examens réalisez-vous dans un premier temps?
- 2- Le bilan complémentaire montre: TA 145/95 mmHg. Purie/Crurie 1 g/mmol (Nal < 0.05 g/mmol) et 4.6 g/24h, protidémie 54 g/l, albuminémie 23 g/l, Cr 121 micromol/l. L'étude du sédiment urinaire en contraste de phase montre 2-3 hématies non déformées. Comment interprétez-vous l'ensemble des données?
- 3- Quelles sont vos principales hypothèses diagnostiques?
- 4- Comment confirmez-vous le diagnostic?
- 5- Quelles précautions prendre avant ce geste?
- 6- Le principal résultat de la ponction-biopsie rénale est indiqué dans la figure. Quel diagnostic reprenez-vous?
- 7- Quel type d'anticorps est souvent associé à ce type de pathologie rénale?
- 8- La recherche d'anticorps est négative. Y-a-t-il d'autres examens à réaliser en priorité?
- 9- Cinq jours après la biopsie rénale, la patiente présente une douleur lombaire aiguë et une hématurie macroscopique. Quelles sont vos 2 principales hypothèses diagnostiques? Quel(s) examen(s) réalisez-vous?
- 10- Citez 3 complications de ce type de pathologie rénale?

Une femme, âgée de 56 ans vous est adressée par son médecin traitant pour oedèmes des membres inférieurs présents depuis au moins 8 mois (prise de 6 Kg; poids actuel 66 Kg). La patiente n'a aucun autre antécédent. Elle a déjà consulté un allergologue et une cardiologue qui n'ont pas retrouvé d'anomalies particulières. Le médecin traitant a réalisé une bandelette urinaire que la patiente vous montre: Protéines +++++, Hématies ++.

- 1- Quels examens réalisez-vous dans un premier temps?
- 2- Le bilan complémentaire montre: TA 145/95 mmHg. Purie/Crurie 1 g/mmol (Nal < 0.05 g/mmol) et 4.6 g/24h, protidémie 54 g/l, albuminémie 23 g/l, Cr 121 micromol/l. L'étude du sédiment urinaire en contraste de phase montre 2-3 hématies non déformées. Comment interprétez-vous l'ensemble des données?
- 3- Quelles sont vos principales hypothèses diagnostiques?
- 4- Comment confirmez-vous le diagnostic?
- 5- Quelles précautions prendre avant ce geste?
- 6- Le principal résultat de la ponction-biopsie rénale est indiqué dans la figure. Quel diagnostic retenir?
- 7- Quel type d'anticorps est souvent associé à ce type de pathologie rénale?
- 8- La recherche d'anticorps est négative. Y-a-t-il d'autres examens à réaliser en priorité?
- 9- Cinq jours après la biopsie rénale, la patiente présente une douleur lombaire aiguë et une hématurie macroscopique. Quelles sont vos 2 principales hypothèses diagnostiques? Quel(s) examen(s) réalisez-vous?
- 10- Citez 3 complications de ce type de pathologie rénale?

Complications du syndrome néphrotique/glomérulonéphrite: thromboses veineuses (artérielles), insuffisance rénale aiguë ou chronique, dyslipidémie, hypertension, œdèmes, etc.

Un homme de 56 ans est adressé pour une hypertension artérielle sévère.

Il pèse 85 Kgs pour 1,69. Il a une histoire de tabagisme à 35 paquets-années.

Il reçoit un traitement par amlodipine, Thiazidique et inhibiteur de l'enzyme de conversion.

Sa TA est de 175/100 mmHg le jour de la consultation.

Sa créatininémie est de 130 mmol/L avec une Kaliémie à 3,4 mmol/l. Protéinurie 0,45 g/24h.

Un homme de 56 ans est adressé pour une hypertension artérielle sévère.
Il pèse 85 Kgs pour 1,69. Il a une histoire de tabagisme à 35 paquets-années.
Il reçoit un traitement par amlodipine, Thiazidique et inhibiteur
de l'enzyme de conversion.

Sa TA est de 175/100 mmHg le jour de la consultation.

Sa créatininémie est de 130 mmol/L avec une Kaliémie à 3,4 mmol/l. Protéinurie 0,45 g/24h.

1. Quels 3 critères principaux permettent de « résumer » une HTA?

Un homme de 56 ans est adressé pour une hypertension artérielle sévère.
Il pèse 85 Kgs pour 1,69. Il a une histoire de tabagisme à 35 paquets-années.
Il reçoit un traitement par amlodipine, Thiazidique et inhibiteur
de l'enzyme de conversion.

Sa TA est de 175/100 mmHg le jour de la consultation.

Sa créatininémie est de 130 mmol/L avec une Kaliémie à 3,4 mmol/l. Protéinurie 0,45 g/24h.

1. Quels 3 critères principaux permettent de « résumer » une HTA?

Son ancienneté.

Les chiffres maximaux de TA systolique et diastolique.

Le nombre de traitements antihypertenseurs.

Un homme de 56 ans est adressé pour une hypertension artérielle sévère.
Il pèse 85 Kgs pour 1,69. Il a une histoire de tabagisme à 35 paquets-années.
Il reçoit un traitement par amlodipine, Thiazidique et inhibiteur
de l'enzyme de conversion.

Sa TA est de 175/100 mmHg le jour de la consultation.

Sa créatininémie est de 130 mmol/L avec une Kaliémie à 3,4 mmol/l. Protéinurie 0,45 g/24h.

1. Quels 3 critères principaux permettent de « résumer » une HTA?
2. Ce patient présente-t-il une HTA « résistante »?

Un homme de 56 ans est adressé pour une hypertension artérielle sévère.
Il pèse 85 Kgs pour 1,69. Il a une histoire de tabagisme à 35 paquets-années.
Il reçoit un traitement par amlodipine, Thiazidique et inhibiteur
de l'enzyme de conversion.

Sa TA est de 175/100 mmHg le jour de la consultation.

Sa créatininémie est de 130 mmol/L avec une Kaliémie à 3,4 mmol/l. Protéinurie 0,45 g/24h.

1. Quels 3 critères principaux permettent de « résumer » une HTA?

2. Ce patient présente-t-il une HTA « résistante »?

Oui, car HTA non contrôlée par une trithérapie incluant un diurétique.

Un homme de 56 ans est adressé pour une hypertension artérielle sévère.
Il pèse 85 Kgs pour 1,69. Il a une histoire de tabagisme à 35 paquets-années.
Il reçoit un traitement par amlodipine, Thiazidique et inhibiteur
de l'enzyme de conversion.

Sa TA est de 175/100 mmHg le jour de la consultation.

Sa créatininémie est de 130 mmol/L avec une Kaliémie à 3,4 mmol/l. Protéinurie 0,45 g/24h.

1. Quels 3 critères principaux permettent de « résumer » une HTA?

2. Ce patient présente-t-il une HTA « résistante »?

3. Le patient vous présente des dosages hormonaux:

Rénine plasmatique x3 normale; Aldostérone plasmatique x2 normale.

Aldostéronurie x2 normale.

Que pensez-vous de ces dosages?

Un homme de 56 ans est adressé pour une hypertension artérielle sévère.
Il pèse 85 Kgs pour 1,69. Il a une histoire de tabagisme à 35 paquets-années.
Il reçoit un traitement par amlodipine, Thiazidique et inhibiteur
de l'enzyme de conversion.

Sa TA est de 175/100 mmHg le jour de la consultation.

Sa créatininémie est de 130 mmol/L avec une Kaliémie à 3,4 mmol/l. Protéinurie 0,45 g/24h.

1. Quels 3 critères principaux permettent de « résumer » une HTA?

2. Ce patient présente-t-il une HTA « résistante »?

3. Le patient vous présente des dosages hormonaux:

Rénine plasmatique x3 normale; Aldostérone plasmatique x2 normale.

Aldostéronurie x2 normale.

Que pensez-vous de ces dosages?

Hyperaldostéronisme secondaire peu spécifique chez ce patient (diurétique)

Un homme de 56 ans est adressé pour une hypertension artérielle sévère.
Il pèse 85 Kgs pour 1,69. Il a une histoire de tabagisme à 35 paquets-années.
Il reçoit un traitement par amlodipine, Thiazidique et inhibiteur
de l'enzyme de conversion.
Sa TA est de 175/100 mmHg le jour de la consultation.
Sa créatininémie est de 130 mmol/L avec une Kaliémie à 3,4 mmol/l. Protéinurie 0,45 g/24h.

1. Quels 3 critères principaux permettent de « résumer » une HTA?
2. Ce patient présente-t-il une HTA « résistante »?
3. Le patient vous présente des dosages hormonaux:
Rénine plasmatique x3 normale; Aldostérone plasmatique x2 normale.
Aldostéronurie x2 normale.
Que pensez-vous de ces dosages?
4. Quel examen-clé réalisez-vous chez ce patient?

Un homme de 56 ans est adressé pour une hypertension artérielle sévère.
Il pèse 85 Kgs pour 1,69. Il a une histoire de tabagisme à 35 paquets-années.
Il reçoit un traitement par amlodipine, Thiazidique et inhibiteur
de l'enzyme de conversion.

Sa TA est de 175/100 mmHg le jour de la consultation.

Sa créatininémie est de 130 mmol/L avec une Kaliémie à 3,4 mmol/l. Protéinurie 0,45 g/24h.

1. Quels 3 critères principaux permettent de « résumer » une HTA?

2. Ce patient présente-t-il une HTA « résistante »?

3. Le patient vous présente des dosages hormonaux:

Rénine plasmatique x3 normale; Aldostérone plasmatique x2 normale.

Aldostéronurie x2 normale.

Que pensez-vous de ces dosages?

4. Quel examen-clé réalisez-vous chez ce patient?

Echographie-doppler rénale pour dépister une sténose des artères rénales.

Un homme de 56 ans est adressé pour une hypertension artérielle sévère.
Il pèse 85 Kgs pour 1,69. Il a une histoire de tabagisme à 35 paquets-années.
Il reçoit un traitement par amlodipine, Thiazidique et inhibiteur
de l'enzyme de conversion.

Sa TA est de 175/100 mmHg le jour de la consultation.

Sa créatininémie est de 130 mmol/L avec une Kaliémie à 3,4 mmol/l. Protéinurie 0,45 g/24h.

1. Quels 3 critères principaux permettent de « résumer » une HTA?

2. Ce patient présente-t-il une HTA « résistante »?

3. Le patient vous présente des dosages hormonaux:

Rénine plasmatique x3 normale; Aldostérone plasmatique x2 normale.

Aldostéronurie x2 normale.

Que pensez-vous de ces dosages?

4. Quel examen-clé réalisez-vous chez ce patient?

5. L'examen n'est pas contributif vu la morphologie du patient?

De quelle alternative disposez-vous? Y-a-t il des précautions particulières à prendre avant la réalisation de cet examen?

Un homme de 56 ans est adressé pour une hypertension artérielle sévère.
Il pèse 85 Kgs pour 1,69. Il a une histoire de tabagisme à 35 paquets-années.
Il reçoit un traitement par amlodipine, Thiazidique et inhibiteur
de l'enzyme de conversion.
Sa TA est de 175/100 mmHg le jour de la consultation.
Sa créatininémie est de 130 mmol/L avec une Kaliémie à 3,4 mmol/l. Protéinurie 0,45 g/24h.

1. Quels 3 critères principaux permettent de « résumer » une HTA?

2. Ce patient présente-t-il une HTA « résistante »?

3. Le patient vous présente des dosages hormonaux:
Rénine plasmatique x3 normale; Aldostérone plasmatique x2 normale.
Aldostéronurie x2 normale.
Que pensez-vous de ces dosages?

4. Quel examen-clé réalisez-vous chez ce patient?

5. L'examen n'est pas contributif vu la morphologie du patient?

De quelle alternative disposez-vous? Y-a-t il des précautions particulières à prendre avant la réalisation de cet examen?

Angioscanner ou artériographie rénale.

Prévention de la toxicité rénale des produits de contraste (maladie rénale chronique): arrêt des diurétiques,
hydratation avec un soluté salé.

6. L'examen réalisé montre les images suivantes. Quelles sont vos conclusions?



6. L'examen réalisé montre les images suivantes. Quelles sont vos conclusions?



Sténose serrée ostiale de l'artère rénale gauche. Rein gauche non atrophique. Artère rénale droite perméable. Calcifications aortiques.

7. Une angioplastie de la sténose rénale gauche est réalisée avec succès. La TA s'améliore après le geste avec des chiffres à 135/75 mmHg en automesure. Le patient n'est pas convaincu par l'utilité de l'automesure. Que lui dites-vous?

On a pu arrêter l'amlodipine. Mais le patient est surpris qu'on soit obligé de poursuivre le thiazidique et le ramipril (IEC). Que lui répondez-vous?

7. Une angioplastie de la sténose rénale gauche est réalisée avec succès. La TA s'améliore après le geste avec des chiffres à 135/75 mmHg en automesure. Le patient n'est pas convaincu par l'utilité de l'automesure. Que lui dites-vous?

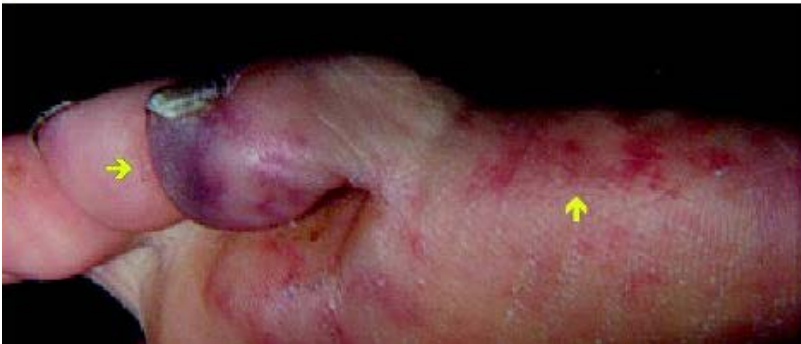
Excellente méthode de mesure de la TA (absence d'effet blouse blanche). Bonne corrélation au risque cardiovasculaire.

On a pu arrêter l'amlodipine. Mais le patient est surpris qu'on soit obligé de poursuivre le thiazidique et le ramipril (IEC). Que lui répondez-vous?

La persistance de l'HTA peut être liée à des lésions vasculaires intra-rénales et/ou en partie à une HTA essentielle.

7. La TA s'améliore après le geste avec des chiffres à 135/75 mmHg en automesure.
Le patient n'est pas convaincu par l'utilité de l'automesure? Que lui dites-vous?
On a pu arrêter l'amlodipine. Mais le patient est surpris qu'on soit obligé
de poursuivre le thiazidique et le Ramipril. Que lui répondez-vous?

8. 10 jours plus tard, le patient vous appelle en urgence.
Sa TA est de nouveau à 175/95 mmHg.
Il a un orteil bleu et douloureux et une « éruption cutanée ».
Sa créatininémie est de 235 mmol/l.
Quel est votre diagnostic? A quoi est due « l'éruption cutanée »?



7. La TA s'améliore après le geste avec des chiffres à 135/75 mmHg en automesure. Le patient n'est pas convaincu par l'utilité de l'automesure? Que lui dites-vous? On a pu arrêter l'amlodipine. Mais le patient est surpris qu'on soit obligé de poursuivre le thiazidique et le Ramipril. Que lui répondez-vous?

8. 10 jours plus tard, le patient vous appelle en urgence.
Sa TA est de nouveau à 175/95 mmHg.
Il a un orteil bleu et douloureux et une « éruption cutanée ».
Sa créatininémie est de 235 mmol/l.
Quel est votre diagnostic? A quoi est due « l'éruption cutanée »?

Probable maladie des « embolies de cholestérol ».

Il s'agit d'un livedo dû à l'obstruction de la microcirculation cutanée par des emboles de cholestérol.

9. En-dehors de l'histoire clinique, quels sont les 3 arguments biologiques qui confortent votre diagnostic?

Comment pouvez-vous confirmer le diagnostic?

9. En-dehors de l'histoire clinique, quels sont les 3 arguments biologiques qui confortent votre diagnostic?
Comment pouvez-vous confirmer le diagnostic?

Syndrome inflammatoire (vs, CRP), hyperéosinophilie, baisse du C3 (complément).
Visualisation des cristaux de cholestérol dans la microcirculation d'un organe (peau, rein, estomac, etc.) grâce à une biopsie ou visualisation des cristaux de cholestérol dans la rétine (fond d'œil).

Le diagnostic repose souvent sur une forte présomption clinique et biologique.

Un homme âgé de 35 ans, infirmier, présente une hématurie macroscopique.

Il consulte quelques jours plus tard la médecine du personnel. Dans le passé, il avait déjà eu 2 épisodes d'hématurie macroscopique.

Huit jours auparavant, il avait présenté une angine avec dysphagie et un état fébrile à 39° C. Simultanément, il avait constaté une hématurie macroscopique, totale et indolore, raison de la consultation.

Examen clinique:

Poids 80 Kg, taille 175 cm. TA: 135/85 mmHg aux 2 bras.

Pas d'oedème, pas de souffle artériel.

Laboratoire:

Sang: créatinine: 188 umol/l, protéines: 71 g/l, albumine: 40 g/l

Urines: claires

- Stix urinaire (bandelette): densité 1010, sang +++, albumine ++, sucre 0
- Sédiment urinaire: hématurie microscopique confirmée
- Récolte urinaire de 24h: protéinurie: 1.8 g/24h

Question 1:

Quel est le syndrome clinique de ce patient ?

1. Syndrome néphritique
2. Syndrome néphrotique
3. Syndrome glomérulaire avec hématurie, protéinurie et insuffisance rénale
4. Syndrome urémique
5. Insuffisance rénale aiguë

Question 1:

Quel est le syndrome clinique de ce patient ?

1. Syndrome néphritique
2. Syndrome néphrotique
3. Syndrome glomérulaire avec hématurie, protéinurie et insuffisance rénale
4. Syndrome urémique
5. Insuffisance rénale aiguë

Question 2:

Quel(s) examen(s) supplémentaire(s) souhaiteriez-vous avoir ?

1. Culture des urines
2. Dosage des chaînes légères dans les urines
3. Sédiment urinaire par contraste de phase
4. Ponction-Biopsie rénale

Question 2:

Quel(s) examen(s) supplémentaire(s) souhaiteriez-vous avoir ?

1. Culture des urines
2. Dosage des chaînes légères dans les urines
3. Sédiment urinaire par contraste de phase
4. Ponction-Biopsie rénale

Question 3:

Quel est le diagnostic le plus vraisemblable ?

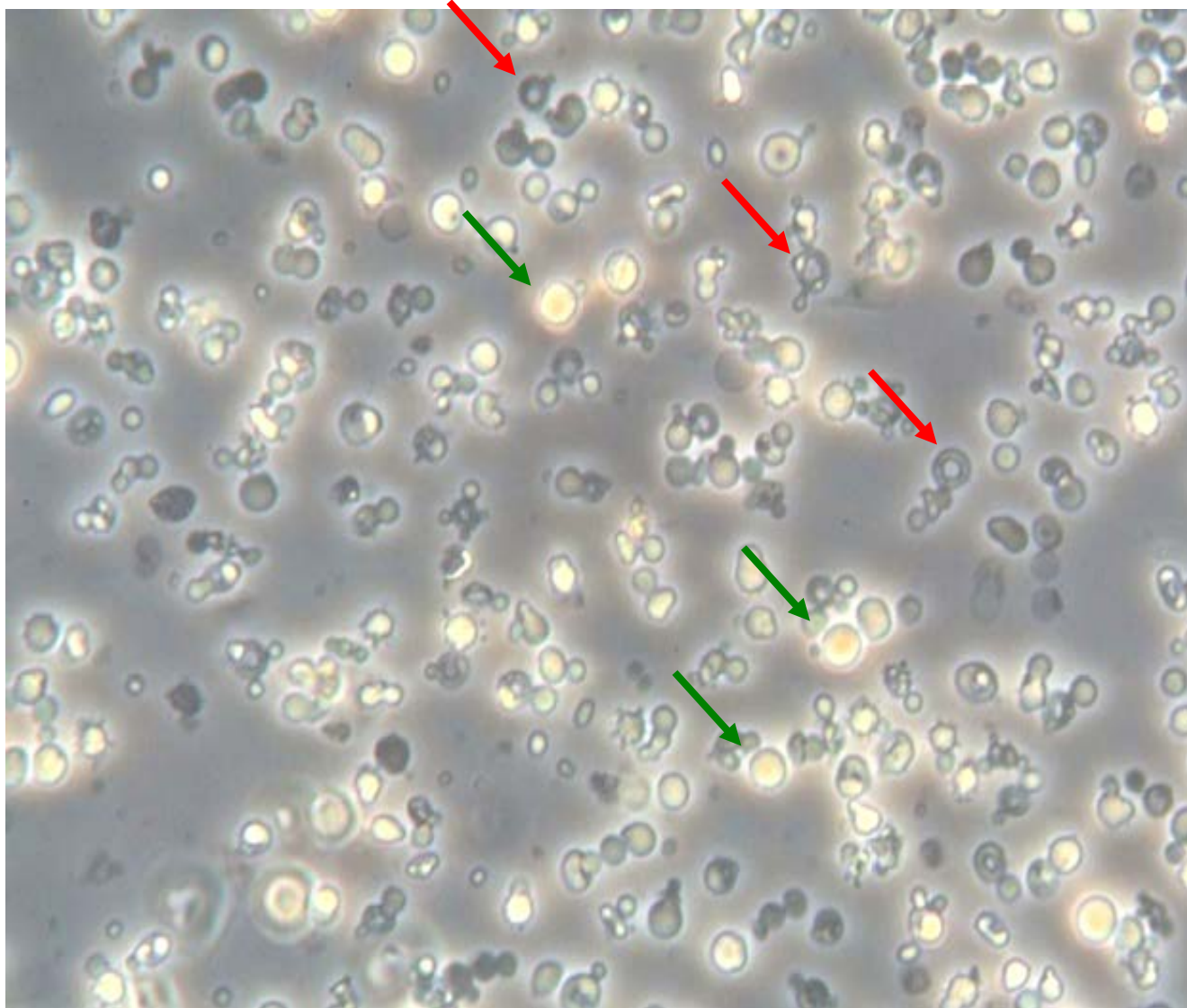
- 1) Glomérulopathie à lésions glomérulaires minimales
- 2) Glomérulonéphrite extra-membraneuse
- 3) Glomérulonéphrite à IgA (néphropathie à IgA)
- 4) Glomérulonéphrite post-streptococcique
- 5) Hyalinose focale et segmentaire

Question 3:

Quel est le diagnostic le plus vraisemblable ?

- 1) Glomérulopathie à lésions glomérulaires minimales
- 2) Glomérulonéphrite extra-membraneuse
- 3) Glomérulonéphrite à dépôts mésangiaux d'IgA (néphropathie à IgA)
- 4) Glomérulonéphrite post-streptococcique
- 5) Hyalinose focale et segmentaire

Sédiment urinaire: microhématurie glomérulaire



Question 4:

Quelle est la filtration glomérulaire estimée de ce patient ?

- 1) $>90 \text{ ml/min/1.73 m}^2$
- 2) entre 60 et 90 ml/min/1.73 m^2
- 3) entre 40 et 60 ml/min/1.73 m^2
- 4) entre 20 et 40 ml/min/1.73 m^2
- 5) $< 20 \text{ ml/min/1.73 m}^2$

Question 4:

Quelle est la filtration glomérulaire estimée de ce patient ?

- 1) $>90 \text{ ml/min/1.73 m}^2$
- 2) entre 60 et 90 ml/min/1.73 m^2
- 3) entre 40 et 60 ml/min/1.73 m^2
- 4) entre 20 et 40 ml/min/1.73 m^2
- 5) $< 20 \text{ ml/min/1.73 m}^2$

Homme de 45 ans qui consulte pour une hypertension artérielle découverte par hasard dans un contrôle d'entreprise. Aucun symptôme.
Patients sportif pas de surcharge pondérale

TA mesurée au cabinet: 142/105, 145/103, 140/99 mmHg, pouls régulier 70/min

Examens de laboratoire:

Sang: Na 140, K 3.2 mmol/l, Calcium 2.25 mmol/l, Créatinine: 80 umol/l
Glycémie et cholestérol normaux.

Examen des urines: normal
Rapport albumine/creatinine: 20 mg/mmol

Echographie rénale: 2 reins de taille normale

Quel sont le(s) diagnostic(s) le(s) plus probable(s) ?

1. Hypertension artérielle essentielle
2. Syndrome de Gitelman
3. Hyperaldostéronisme primaire
4. Hypertension sur abus de réglisse

Quel sont le(s) diagnostic(s) le(s) plus probable(s) ?

1. Hypertension artérielle essentielle
2. Syndrome de Gitelman
3. Hyperaldostéronisme primaire
4. Hypertension sur abus de réglisse

Quel(s) examen(s) complémentaire(s) effectué(s) pour clarifier l'origine de l'hypokaliémie ?

1. Urines de 24 H avec dosage des électrolytes (Na, K, Ca)
2. Dosage de l'activité de la rénine plasmatique
3. Dosage de l'aldostérone plasmatique
4. Dosage de la rénine et de l'aldostérone
5. Dosage de la réglisse dans le sang

Quel(s) examen(s) complémentaire(s) effectué(s) pour clarifier l'origine de l'hypokaliémie ?

1. Urines de 24 H avec dosage des électrolytes (Na, K, Ca)
2. Dosage de l'activité de la rénine plasmatique
3. Dosage de l'aldostérone plasmatique
4. Dosage de la rénine et de l'aldostérone
5. Dosage de la réglisse dans le sang

Différentes formes d'hyperaldostéronisme

	Rénine	Aldostérone
Hyperaldostéronisme primaire	↓	↑
Pseudohyperaldostéronisme	↓	↓
Hyperaldostéronisme secondaire	↑	↑

Une femme de 68 ans, hospitalisée pour une histoire de deux semaines de douleurs abdominales supérieures et de la fièvre. Une radiographie de contraste des intestins révèle une large masse s'appuyant sur le duodénum, ce qui est confirmé par une angiographie coeliaque. Elle subit une laparotomie exploratoire et un abcès pancréatique est découvert et drainé.

Quatre jours plus tard, elle reste fébrile, malgré les antibiotiques reçus et on constate que sa diurèse est en moyenne de 200-400 ml/24h.

Résultats de laboratoires sanguins:

Urée 19.2 mmol/l, créatinine 168 μ mol/l, sodium 130, chlorures 92, potassium 3.0 et HCO_3^- : 28 mmol/l.

Analyses urinaires: densité 1.020 g/l, Sodium 4 mmol/l, chlorure 6 et potassium 40 mmol/l.

Questions

- a) Quels facteurs peuvent avoir contribué à l'augmentation de la créatininémie ?
- b) Pourquoi le sodium urinaire est bas?
- c) Pourquoi le potassium urinaire est relativement élevé?
- d) Que pensez-vous de la concentration urinaire?

Questions

a) Quels facteurs peuvent avoir contribué à l'augmentation de la créatininémie ?

L'atteinte digestive, la chirurgie, la fièvre, responsables d'une déshydratation (insuffisance rénale aiguë fonctionnelle). L'injection du produit de contraste (angiographie).

b) Pourquoi le sodium urinaire est bas?

c) Pourquoi le potassium urinaire est relativement élevé?

La déshydratation entraîne un hyperaldostérionisme secondaire avec une réabsorption rénale de sodium en échange d'une perte urinaire de potassium.

d) Que pensez-vous de la concentration urinaire?

Les urines sont concentrées. Le rein élimine le maximum de déchets (créatinine, urée) avec le volume d'eau minimal.

Histoire clinique

Un patient de 59 ans, connu pour une HTA traitée depuis plusieurs années, et une maladie rénale chronique de stade G3a. Il a été perdu de vue pendant deux ans puis a été réadressé par son médecin de famille pour une diminution de l'état général, une fatigue/asthénie, une perte d'appétit, une perte de poids, des nausées matinales et un prurit ces dernières semaines.

Examen clinique

Patient apathique, pâle, poids 74 kg (-3 kg) mais présence d'oedèmes des membres inférieurs importants.

TA de 155/90 mm Hg, pulsations: 76/min régulières

Auscultation cardio-respiratoire physiologique, abdomen sp

Pas d'adénopathie, pas de lésions cutanées.

Les examens biologiques montrent:

sang

- créatinine 800 $\mu\text{mol/l}$
- urée 48 mmol/l
- Na 140 mmol/l
- K 6.6 mmol/l,
- HCO_3^- 13 mmol/l
- Ca corrigé 2.02 mmol/l
- P 1.95 mmol/l
- PTH à 4 fois la norme supérieure.
- Hb 80g/l

L'échographie montre deux reins dédifférenciés et atrophiques

urines

protéines +++, pas de sang.

Quel est le stade la maladie rénale chronique de ce patient?

Quels signes cliniques peuvent être expliqués par la maladie rénal chronique de ce patient?

Quelles anomalies biologiques sanguines présente ce patient?

Comment pouvez-vous corriger ou améliorer ces anomalies biologiques?

Quel est le stade la maladie rénale chronique de ce patient?

Stade 5.

Quels signes cliniques peuvent être expliqués par la maladie rénal chronique de ce patient?

Diminution de l'état général, fatigue/asthénie, perte d'appétit, perte de poids, nausées matinales, prurit.

Quelles anomalies biologiques sanguines présente ce patient?

Elévation de la créatininémie et de l'urée, hyperkaliémie, baisse des bicarbonates sanguins (probable acidose métabolique), hypocalcémie et hyperphosphorémie, hyperparathyroïdie (secondaire), anémie.

Comment pouvez-vous corriger ou améliorer ces anomalies biologiques?

Elévation de la créatininémie et de l'urée: dialyse.

Hyperkaliémie: résine échangeuse d'ions, apport de bicarbonates.

Baisse des bicarbonates sanguins: apport de bicarbonates.

Hypocalcémie et hyperphosphorémie, hyperparathyroïdie (secondaire): apport de carbonate de calcium pour un apport de calcium, une chélation du phosphore et une freination de la PTH. Dans un deuxième temps chélateurs non calciques du phosphore et vitamine D. Calcimimétiques.

Anémie: apport en fer (folates et vitamine B12 si besoin) et erythropoïetine.